

DOLOR ABDOMINAL

Alberto Moran Blanco

INTRODUCCIÓN

Sin duda el dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más frecuente en los servicios de urgencias.

Las causas son numerosas y es primordial una valoración sistemática para descartar de inicio las más graves, pues es un síntoma muy inespecífico.

Lo primero es considerar el dolor abdominal agudo que es aquel de instauración en pocas horas, de intensidad alta y que suele tener una causa intraabdominal y que requiere un diagnóstico precoz y posiblemente una actitud quirúrgica. Por ello, hay que valorar el estado general del paciente en base a su estabilidad hemodinámica, q-sofa y/o defensa abdominal que determinaran una actuación inmediata, probablemente por Cirugía General o la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ante la ausencia de estos datos de alarma tendremos que valorar de forma ordenada aquellos procesos que pudiendo manifestarse de forma poco llamativa sean muy graves como son la presencia de un aneurisma de aorta abdominal roto o una isquemia intestinal. A continuación hay que pensar en la posibilidad de una obstrucción o perforación intestinal. Finalmente sino llegamos a una orientación en uno de estos procesos nos guiaremos por la localización del dolor para interpretar las posibilidades diagnósticas.

El dolor vascular (aneurisma roto o isquemia mesentérica) es de instauración agudo, constante e intenso, difícil de localizar y se caracteriza por una exploración física anodina y una rápida evolución con afectación del estado general.

La peritonitis infecciosa (apendicitis) o por perforación de víscera hueca (úlcera gastroduodenal, cuerpo extraño) es agudo, constante e intenso, fácil de localizar y hay contractura muscular (defensa de pared abdominal) y el paciente está inmóvil.

En la obstrucción intestinal (neoplasia, bridas) el dolor es intermitente, progresivo, mal localizado y se acompaña de náuseas y vómitos. Este patrón es válido también para los dolores cólicos (biliar o renal), diverticulitis, gastroenteritis o hernias entre otros.

Aspectos Que No Debemos Olvidar:

En los antecedentes personales las cirugías previas (obstrucción intestinal), los factores de riesgo cardiovascular (aneurisma abdominal, isquemia intestinal), los hábitos tóxicos (ascitis por cirrosis) y los fármacos (AINEs, anticoagulantes) que toma de forma habitual o esporádica.

En la **anamnesis** del cuadro como son el inicio (horas vs días), las características del dolor (cólico o progresivo), los síntomas asociados (vómitos, diarrea, fiebre, ictericia, clínica miccional, pérdida de peso). Tener en cuenta que si los vómitos preceden al dolor la causa probablemente será médica, aunque no necesariamente.

En la **exploración física** es fundamental una exploración física ordenada (**inspección, auscultación, percusión y palpación: superficial y profunda**), una valoración abdominal comenzando por la presencia de peristaltismo (ausencia o ruidos metálicos), localización del dolor, palpación abdominal detectando la presencia de contractura muscular o rebote doloroso (peritonitis, perforación víscera hueca), de hernias (reducibles o no), o de soplos abdominales o femorales (aneurismas, estenosis vasculares), los pulsos arteriales (asimetrías) y por último el tacto rectal (masas, presencia de sangre y/o dolor).

DIAGNÓSTICO.

El diagnóstico se basa en la historia clínica (anamnesis) y la exploración física. Las pruebas de laboratorio y radiología nos ayudan a establecerlo y su solicitud debe ir dirigida ante la sospecha clínica.

Pruebas complementarias

- **Hemograma** con formula leucocitaria.
- **Bioquímica:** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, lipasa, PCR, procalcitonina. Si clínica sugestiva de patología isquémica: CKmb y troponina US.
- **Coagulación** básica.
- **Gasometría** arterial (acidosis en isquemia intestinal).
- **Sistemático y sedimento de orina**, test de embarazo en contexto adecuado.
- **ECG:** ante todo dolor abdominal alto (epigastrio) hay que realizar un ECG para descartar un infarto de miocardio.
- **Radiografía de tórax PA y Lateral.** Descartar neumoperitoneo, neumotórax, neumonías basales, derrame pleural, hernias diafragmáticas.
- **Radiografía de abdomen.** Son importantes como estudios iniciales para descartar causas a distancia (neumonías), neumoperitoneo (perforación de víscera hueca), obstrucción intestinal (hacer radiografía en bipedestación y sino es factible en decúbito lateral izquierdo), calcificaciones vasculares o litiasis biliar y renal.
- **Ecografía abdominal.** Según clínica
- **TC abdominal.** Si dudas diagnósticas con estudios previos, son estudios que habrá que solicitar de forma dirigida.
- **Endoscopia o colonoscopia:** al igual que los estudios previos según clínica y sospecha diagnóstica: hemorragia digestiva.

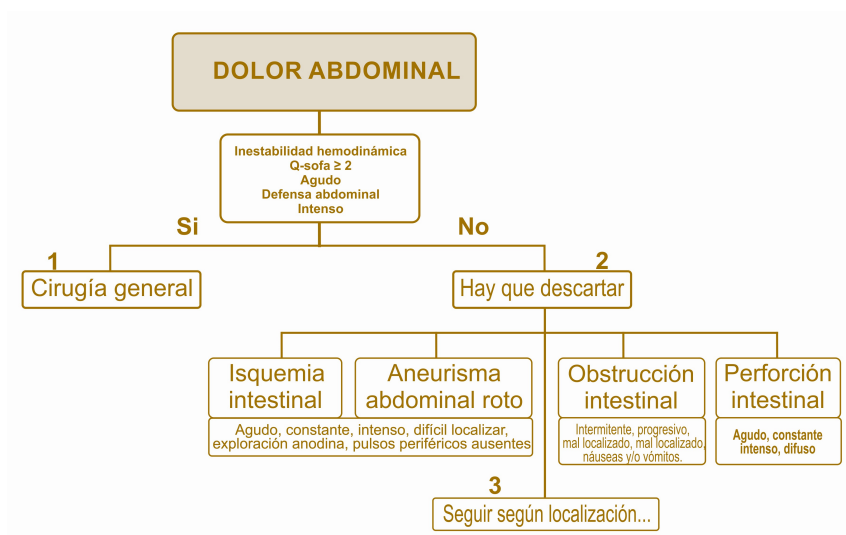
TRATAMIENTO

El tratamiento será el de la causa bien sea quirúrgico o médico. Ante un dolor abdominal inespecífico sin una causa justificable puede ser necesaria la observación durante unas horas siendo remitido posteriormente a su domicilio si no aparecen signos de alarma.

Evitar en la medida de lo posible la analgesia en el dolor abdominal agudo de causa imprecisa para evitar enmascarar los hallazgos clínicos y/o retrasar el diagnóstico. Si la intensidad del dolor es importante debe primar la comodidad del paciente y por tanto analgesiar.

- ¡IMPORTANTE!. ¡Ojo! Con dolor de instauración en horas y que cursa con afectación del estado general, hipotensión arterial y/o defensa abdominal.

Algoritmo diagnóstico del dolor abdominal



BIBLIOGRAFÍA

- Penner RM, Fishman MB. Evaluation of the adult with abdominal pain. In: UpToDate, Auerbach AD, Aronson MD (Ed). Waltham, MA. Disponible en: www.uptodate.com (Accessed on April 2018).
- Mehta SJ. Dolor abdominal. En: Friedman HH, coordinador. Manual de Diagnóstico Médico. 5ª ed. Barcelona: Masson; 2004. p.183-90.
- Silen W. Dolor abdominal. En: Longo DL, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL, Jameson JL, Loscalzo J, editores. Harrison. Principios de Medicina Interna. Vol 1. 18º ed. México: McGraw-Hill; 2012. p 108-112.